

Die autistische, monotrope Person über die Lebensspanne begleiten

Ein Leitfaden für Praktiker und Gesundheitsfachleute

Zweck. Dieser Leitfaden erklärt, was ein autistisch monotroper Geist ist, wie sich seine Merkmale über die Lebensspanne verändern und wie Praktiker und Gesundheitsfachleute mit autistischen Menschen **interagieren, sie anregen (einbeziehen) und unterstützen** können – von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter. Er gründet auf der **Monotropismus**-Theorie des Autismus – einem aufmerksamkeitsbasierten, neuroaffirmierenden Ansatz, entwickelt von den autistischen Forscherinnen und Forschern Dinah Murray, Wenn Lawson und Mike Lesser (2005) – und auf begutachteter Evidenz sowie klinischer/Praxis-Leitlinien, wo diese existieren. Er ersetzt keine individualisierte Diagnostik; jeder autistische Mensch ist anders.

Ein Hinweis zur Sprache. Dieser Leitfaden verwendet **identitätsfirst-Sprache** („autistische Person“), den Vorzug der Mehrheit der autistischen Community und vereinbar mit der Quelltheorie. Manche Individuen und Familien bevorzugen Person-first-Sprache („Person mit Autismus“); folgen Sie der Präferenz der einzelnen Person. Der Leitfaden vermeidet bewusst defizitorientierte Begriffe („gestört“, „defizitär“, „Symptom“), außer wenn er klinische Kriterien zitiert, und beschreibt stattdessen Unterschiede mit Stärken und Herausforderungen. Monotropismus ist eine Linse; eine Minderheit autistischer Menschen findet, sie beschreibe sie nicht, und er sollte das Zuhören beim Individuum ergänzen, nicht ersetzen.

Teil 1 — Was ist ein autistisch monotoner Geist?

Monotropismus geht davon aus, dass Geister als **Interessensystem** arbeiten: Wir werden von vielem angezogen, diese Interessen ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich, und **Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource**, um die mentale Prozesse konkurrieren (Murray, Lesser & Lawson, 2005). Der Unterschied zwischen autistischer und nicht-autistischer Kognition wird als Unterschied darin gefasst, *wie Aufmerksamkeit verteilt wird*, nicht als Defizit.

„In jedem Moment ist die einem bewussten Individuum zur Verfügung stehende Aufmerksamkeit begrenzt. Es gibt Wettbewerb zwischen mentalen Prozessen um diese knappe Ressource.“ — Murray, Lesser & Lawson (2005), über die National Autistic Society (NAS, 2025).

Ein **monotroper Geist** tendiert dazu, **wenige Interessen zugleich** zu erregen, aber jedes aktive Interesse fängt einen **unverhältnismäßigen, intensiven Anteil** der Verarbeitungsressourcen ein und erzeugt einen engen, tiefen „**Aufmerksamkeitstunnel**“. Alles außerhalb des Tunnels wird minimal verarbeitet. Ein **polytroper Geist** (die häufigere, nicht-autistische Art) verteilt Aufmerksamkeit über mehr Interessen und wechselt flüssiger zwischen ihnen (Murray, Lesser & Lawson, 2005; F. Murray, 2018).

Die Theorie macht drei Kernvorhersagen, die sich auf alltägliche autistische Erfahrung abbilden (F. Murray, 2018; Dwyer, 2025; NAS, 2025):

1. **Intensität im Tunnel** — lebendiger, tiefer Fokus, der Expertise, Kreativität und **Flow**-Zustände trägt.
2. **Verminderte Verarbeitung außerhalb des Tunnels** — Reize, soziale Signale und sogar innere Signale (Hunger, Schmerz, Toilettenbedarf) registrieren vielleicht nicht.
3. **Schwierigkeit beim Wechseln** — Übergänge zwischen Aufmerksamkeitszuständen sind langsam und mühsam; das ist **autistische Trägheit**.

1.1 Das charakteristische Profil auf einen Blick

Bereich	Monotropismus-informiertes Merkmal
Aufmerksamkeit / Interesse	Tiefer, enger Fokus; wenige simultane Spuren; „Spezialinteressen“ sind zentral, freudvoll und bedeutsam, nicht peripher
Sensorik	Hyperreaktivität (ein eindringlicher, im Tunnel eingefangener Reiz wird intensiv gespürt); Hyporeaktivität (woanders vertieft, registrieren Reize/Schmerz vielleicht nicht); sensorisches Suchen (ein angenehmer Reiz im Tunnel wird intensiv verfolgt) — eine <i>vereinheitlichte</i> Erklärung
Interozeption & Körper	Verminderte Wahrnehmung von Hunger, Durst, Schmerz, Erschöpfung, Toilettenbedarf im Flow („Interozeptions-Diskonnekt“)
Wechseln / exekutive Funktion	Autistische Trägheit — Schwierigkeit zu beginnen, zu stoppen oder die Spur zu wechseln; keine generische „exekutive Dysfunktion“
Sozial / Kommunikation	Mehrkanalige soziale Verarbeitung ist kostenintensiv; wörtliche Interpretation; Bedürfnis nach Verarbeitungszeit; das Doppelt-Empathie-Problem bedeutet, dass Missverständnis <i>bidirektional</i> ist, kein autistisches Defizit
Routinen & Stimming	Routinen reduzieren konkurrierende Entscheidungen und mentale Last; Stimming liefert vorhersagbaren, selbstkontrollierten Input, der Überlastung filtert und Gleichgewicht wiederherstellt
Stärken	Expertise, Mustererkennung, anhaltende Konzentration, Flow, Ehrlichkeit, Wissenstiefe, kreatives Versenken

1.2 Die Wohlbefindens-Risiken, die daraus folgen

Den *Mechanismus* zu verstehen macht die Risiken vorhersagbar und — entscheidend — vermeidbar:

- **Monotroper Split** (ein Begriff, geprägt von Tanya Adkin): die mentale Dissonanz und Erschöpfung daraus, Aufmerksamkeit in polytroper Weise teilen oder schnell wechseln zu müssen; er „kann kurz- und langfristig verheerende Wirkungen haben“ (F. Murray, 2023).
- **Meltdowns und Shutdowns** sind **unwillkürliche** Reaktionen des Nervensystems auf Überlastung, keine Verhaltensentscheidungen oder „Wutanfälle“. Ein **Meltdown** ist sichtbar (Weinen, Rufen, Auf-

und-ab-Gehen, Stimming, Fluchtversuche); ein **Shutdown** ist das verinnerlichte Spiegelbild — Rückzug, Reaktionslosigkeit, Disengagement, ein schützendes „Ausschalten“ zur Energiekonservierung (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism). Beide erfordern beträchtliche **Erholungszeit** (mitunter Tage) und werden durch Unverständnis anderer verschlimmert.

- **Autistisches Burnout** ist „ein Syndrom ... als Folge chronischen Lebensstresses und einer Diskrepanz zwischen Erwartungen und Fähigkeiten ohne angemessene Unterstützung“, gekennzeichnet durch **umfassende, langfristige (typischerweise 3+ Monate) Erschöpfung, Funktionsverlust und verminderte Reiztoleranz** (Raymaker et al., 2020). Es ist **vom beruflichen Burnout und von klinischer Depression zu unterscheiden**, ist mit **suizidalem Verhalten** verknüpft und wird verschlimmert, wenn autistische Züge durch **Masking/Camouflaging** gelehrt werden. Erholung hängt mit **Akzeptanz und sozialer Unterstützung, Auszeiten/verringerten Erwartungen und ‚Dinge auf autistische Art tun‘/Entmasken** zusammen (Raymaker et al., 2020).
- **Masking / Camouflaging** (autistische Züge verbergen, um nicht-autistisch zu wirken) ist erschöpfend und mit Angst, Depression und verpasster Diagnose verknüpft — besonders bei Mädchen und Frauen, die häufiger zur Maskerade sozialisiert werden (F. Murray, 2023; Pearson & Rose, 2021; Bradley et al., 2021).
- **Grübeln / „Schleifen der Sorge“**: Dieselbe Tunnelung, die tiefes Interesse erzeugt, kann sich auf Sorgen und Ängste fixieren (Hallett, 2021; F. Murray, 2023).

1.3 Evidenzstatus (seien Sie ehrlich zu sich selbst und zu Klientinnen und Klienten)

Monotropismus hallt stark mit autistischem gelebtem Erleben nach und wird in der Forschung zunehmend zitiert, aber er bleibt eine **deskriptive** Theorie mit begrenztem direktem experimentellem Test und einer unreifen Messbasis — der **Monotropism Questionnaire** (Garau et al., 2023) ist das einzige gewidmete Instrument und noch in der Reifung (Dwyer, 2021; Dwyer, 2025). Stützende konvergente Evidenz umfasst „klebrige“/verlangsamte Ablösung der Aufmerksamkeit bei autistischen Kindern (Landry & Bryson, 2004; Metaanalyse: Sacrey et al.,

2015) und eine entstehende Literatur zum **autistischen Flow** (Heasman et al., 2024). Behandeln Sie Monotropismus als eine mächtige *klinische Heuristik* — nicht als diagnostisches Etikett.

Teil 2 — Querschnittsprinzipien für jede Praktikerin und jeden Praktiker

Vor den altersspezifischen Abschnitten: Diese Prinzipien gelten **auf jeder Lebensstufe und in jedem Setting**. Sie sind der praktische Kern von „gut mit einer monotropen Person interagieren und umgehen“.

1. **Begegnen Sie ihnen dort, wo ihre Aufmerksamkeit ist.** Die am häufigsten zitierte praktische Implikation des Monotropismus ist es, *mit dem aktuellen Interesse der Person zu arbeiten statt gegen es*. Interessen sind „Hebel“, keine Hindernisse, die umzuleiten wären (F. Murray, 2018; Wood, 2019; Lawson). „*Behandle Interessen als etwas, mit dem man arbeitet*“ (F. Murray, 2018).
2. **Schützen Sie den Aufmerksamkeitstunnel; minimieren Sie den „monotropen Split“.** Vermeiden Sie Unterbrechungen, erzwungenes schnelles Aufgabenwechseln und unnötiges Multitasking. Wo ein Wechsel unvermeidbar ist, geben Sie **Warnungen und Übergangszeit** (siehe §3). Wie der autistische Ingenieur Jamie Knight Arbeitsplatzplanung fasst: bauen Sie **„Tunnel statt Aufgaben“**, und lassen Sie *die Umwelt einen Raum öffnen, durch den der Tunnel laufen kann*, statt die Person zwingen, sich durchzugraben (Knight, 2021/2022).
3. **Achten Sie tiefe Interessen als Wohlbefindens-Ressourcen.** Spezialinteressen liefern Freude, Stabilität, Identität, Lernen und Erholung vom Burnout; sie sind keine „Zwänge“, die zu begrenzen wären (F. Murray, 2023; Mantzalas et al., 2022). Den Zugang zu ihnen zu reduzieren ist ein klinisches Risiko, keine Behandlung.
4. **Reduzieren Sie unnötige sensorische Last** und gestalten Sie zugängliche Umwelten (weniger Lärm/visuelles Durcheinander; erlauben Sie ruhige, schwach beleuchtete Räume; meiden Sie fluorescenten Glanz und starke Gerüche, wo möglich) (NAS, 2025; F. Murray, 2023).
5. **Kommunizieren Sie klar und wörtlich.** Sagen Sie, was Sie meinen; meiden Sie Sarkasmus, indirekte Bitten und starke Abhängigkeit vom

Tonfall/Mimik allein; gewähren Sie **zusätzliche Verarbeitungszeit**; bieten Sie Informationen schriftlich an. Setzen Sie eine langsame Antwort nicht mit Desinteresse oder Unverständnis gleich (F. Murray, 2023).

6. **Praktizieren Sie die Doppelt-Empathie-Haltung.** Erkennen Sie an, dass Kommunikationszusammenbrüche **bidirektional** sind (Milton, 2012). Wenn in der Interaktion etwas schiefgeht, fragen Sie, was Sie vielleicht übersehen, statt es dem Defizit der autistischen Person zuzuschreiben.
7. **Stärken Sie Handlungsfähigkeit und Authentizität; erzwingen Sie kein Masking.** Reduzieren Sie den Druck, als nicht-autistisch „durchzugehen“. Stims oder natürliche Kommunikation zu unterdrücken ist schädlich (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020; Pearson & Rose, 2021).
8. **Bauen Sie Vorhersagbarkeit und Routinen mit der Person auf, nicht über sie.** Verordnete Routinen schlagen oft fehl; gemeinschaftlich geschaffene Routinen reduzieren Entscheidungs last und werden begrüßt (F. Murray, 2022).
9. **Planen Sie Erholung ein.** Rechnen Sie nach fordernden Ereignissen (Klinikbesuchen, Übergängen, sozialen Anforderungen) mit Auszeiten und erlauben Sie diese, Stimming und Zugang zu Interessen.
10. **Hören Sie dem Individuum als der Expertin bzw. dem Experten für das eigene Erleben zu.** Selbstbericht ist primäre Evidenz; der Monotropism Questionnaire (Garau et al., 2023) kann ein nützlicher *Gesprächseinstieg* sein, keine Diagnostik.

Teil 3 — Der Lebensspannen-Leitfaden

Jeder Abschnitt behandelt: **(a) was Sie beobachten könnten, (b) wie Sie interagieren, (c) wie Sie anregen / einbeziehen, und (d) wie Sie unterstützen / mit Herausforderungen umgehen.**

3.1 Frühe Kindheit (etwa 0–5 Jahre)

(a) Was Sie beobachten könnten. Intensiver Fokus auf bestimmte Objekte/Themen; früh auftretende intensive Interessen (oft früher als bei nicht-autistischen Kindern); Aufreihen, Sortieren, Kategorisieren und

Muster-Bilden als Spiel; verminderte oder atypische gemeinsame Aufmerksamkeit und Namensreaktion; **verlangsamte Ablösung der Aufmerksamkeit** („klebriger Blick“) — von der Säuglingszeit messbar und eines der frühesten Zeichen; sensorische Hyper- oder Hyporeaktivität; Routinen und repetitives Spiel; Meltdowns bei Übergängen. Ein monotropes Kleinkind kann tief vertieft sein und vieles außerhalb des Tunnels verpassen, einschließlich Hunger, Schmerz oder dass ein Elternteil den Raum verlässt (Landry & Bryson, 2004; F. Murray, 2023; Donzelli, 2021; Lawson, zur Objektpermanenz).

(b) Wie Sie interagieren. Treten Sie in den Aufmerksamkeitstunnel des Kindes ein, statt es herauszuziehen — **treten Sie seinem Spiel und seinem Interesse zuerst bei**, und erweitern Sie von dort behutsam. Nutzen Sie das Interesse, um Verbindung und gemeinsame Aufmerksamkeit aufzubauen (Lawson). Halten Sie Sprache klar, langsam und wörtlich; gewähren Sie Verarbeitungszeit; erzwingen Sie keinen Blickkontakt (Blickkontakt kann selbst knappe Aufmerksamkeitsressourcen verbrauchen) (F. Murray, 2023). Reduzieren Sie die sensorische Last im Raum.

(c) Wie Sie anregen / einbeziehen. Nutzen Sie das **intensive Interesse des Kindes als Brücke zu Lernen und Kompetenzaufbau** — Sequenzieren, Sprache, Zählen, Motorik und Spielkompetenzen können alle *durch* das Interesse geübt werden (Lawson; Wood, 2019; BERA, zu Flow-Zuständen im Klassenzimmer). Unterstützen Sie entstehende **gemeinsame Aufmerksamkeit** durch interessen-geleitetes, beziehungsorientiertes Spiel und Frühintervention (das JASPER-Modell und ähnliche interessen-/spielbasierte Ansätze zielen auf gemeinsame Aufmerksamkeit und symbolisches Spiel; Kasari et al., 2006). Achten Sie **autistische Spielkultur** — Aufreihen, Sortieren und sensorische Erkundung sind gültiges Spiel, kein „falsches“ Spiel, das zu korrigieren wäre (Donzelli, 2021).

(d) Wie Sie unterstützen / umgehen. Managen Sie **Übergänge** mit visuellen Zeitplänen/Timer, Countdowns, verbalen + visuellen Warnungen *vor* dem Wechsel, „Brücken“-Objekten von einer Aktivität zur nächsten und Extrazeit; reißen Sie ein Kind nie abrupt aus einem Aufmerksamkeitstunnel (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Bei **Meltdowns**: bleiben Sie ruhig, reduzieren Sie Stimulation, werten Sie nicht und bestrafen Sie nicht — sie sind unwillkürlich; sichern Sie

Sicherheit, dann erlauben Sie Erholung (Autism Society, 2025). Schützen Sie den Zugang zu Stimming (es ist Selbstregulation) (F. Murray, 2023). Meiden Sie Compliance-basierte Programme, die Stims oder natürliche Verhaltensweisen abtrainieren: diese erhöhen Masking und langfristigen Schaden (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).

3.2 Schulkindalter (etwa 6–12 Jahre)

(a) Was Sie beobachten könnten. Die Schule ist oft der erste anhaltende Stresstest eines monotropen Systems und ist „die Hölle für viele monotrope Kinder — obwohl viele von uns gerne lernen“ (F. Murray, 2023). Klassenzimmer, Flure und Pausen sind typischerweise **zu laut, zu visuell belebt und zu unvorhersehbar** und verbrauchen Aufmerksamkeit, die dem Lernen zustehen sollte. Kinder könnten bei Übergängen „sich falsch verhalten“, sich in Pausen zurückziehen, wegen „seltsamer“ Interessen oder selbstbestimmten Spiels gemobbt werden oder vom Personal als trotzig, faul oder desinteressiert missverstanden werden. Trägheit zeigt sich als Schwierigkeit, Arbeit zu beginnen, Fächer zu wechseln oder zusammenzupacken. Manche Kinder beginnen hier stark zu masken, mit psychischen Kosten (F. Murray, 2023; Leatherland, 2019; NAS, 2025).

(b) Wie Sie interagieren (Lehrkräfte, Schulkrankenschwestern, Therapeutinnen und Therapeuten). Erkennen Sie, dass Widerstand bei Übergängen ein **kognitive-Kosten**-Problem ist, keine Trotz. Bieten Sie ruhige/schwach beleuchtete Räume (z. B. „Aufgaben“ in der Bibliothek in der Pause, eine Ruhe-Ecke). Bauen Sie Beziehungen über das Interesse des Kindes auf. Kommunizieren Sie wörtlich, im Voraus und, wo möglich, schriftlich. Modellieren Sie die Doppelt-Empathie-Haltung für Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Kolleginnen und Kollegen — rahmen Sie Unterschiede als Unterschiede, nicht als Defizite (F. Murray, 2023; Wood, 2019).

(c) Wie Sie anregen / einbeziehen (das „monotrope Curriculum“). Machen Sie das **Spezialinteresse zur Wirbelsäule des Lernens**: lehren Sie Lesen, Schreiben, Mathematik, Geschichte und Naturwissenschaften *durch* das Interesse; erlauben Sie ausgedehnte Zeit im interessen-geleiteten Flow; gestalten Sie Aufgaben um weniger, tiefere Spuren statt ständigen Wechsel (Wood, 2019, „intensive Interessen ... der Schlüssel zur schulischen Inklusion“; F. Murray, „Monotropism at School“, 2019;

BERA). Flow-Zustände sind Lernzustände — schützen Sie sie: „*wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler überfordert fühlt ... und Sie wissen, dass sie/er ein monotropes Interesse an Lego hat, warum dann keinen ruhigen Raum schaffen ... und ausgedehnte Zeit erlauben?*“ (BERA). Verbinden Sie sich mit einer leidenschaftlichen autistischen Lernenden über die Leidenschaft (Wood et al., 2022; Lawson).

(d) Wie Sie unterstützen / umgehen. Nutzen Sie visuelle Zeitpläne, Übergangswarnungen und Brücken-Aktivitäten; geben Sie großzügige Übergangszeit und reduzieren Sie, wo möglich, die Zahl der Übergänge pro Tag (Autism Little Learners; F. Murray, 2023). Schaffen Sie Routinen *gemeinsam mit dem Kind*. Achten Sie auf **autistisches Burnout und „Kompetenzrückgang“** bei Schulkindern — diese spiegeln oft Überlastung und eine Verlagerung der Aufmerksamkeitsressourcen wider, nicht den Verlust angeborener Fähigkeit, und die Antwort ist, **Anforderungen zu reduzieren und den Zugang zu Interessen/Ruhe wiederherzustellen**, nicht härter zu drängen (Edgar, 2024; Raymaker et al., 2020). Identifizieren und reduzieren Sie Masking-Druck, besonders bei Mädchen, die häufig übersehen werden, weil sie masken (F. Murray, 2023). Nutzen Sie eine Lehrer-Burnout-Leitlinie (z. B. Edgar, 2023) und ziehen Sie Eltern als Expertinnen und Experten ihres Kindes hinzu.

3.3 Adoleszenz (etwa 13–18 Jahre)

(a) Was Sie beobachten könnten. Die Pubertät bringt hormonelle und Hirnveränderungen (synaptisches Beschneiden, Myelinisierung), die sensorische und emotionale Reaktionen intensivieren und ein etabliertes Gleichgewicht stören können. Die sozialen Anforderungen der Adoleszenz — wechselnde Peer-Hierarchien, implizite soziale Regeln, Daten, Identitätsbildung — sind extrem vielspurig und erschöpfend für ein monotropes System. Psychische Schwierigkeiten (Angst, Depression) gipfeln hier; Grübeln / „Schleifen der Sorge“ kann sich verfestigen; Camouflaging intensiviert sich, und viele autistische Mädchen und marginalisierte Geschlechter-Jugendliche werden **erst in der Krise erkannt**. Spezialinteressen werden zentral für Identität und Erholung. Freundschaften sind, wenn von hoher Qualität, schützend für die psychische Gesundheit (ARI, zur Pubertät; Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023; Hallett, 2021; Sedgewick/Cook et al., via PMC9597130).

(b) Wie Sie interagieren. Behandeln Sie die junge Person als Expertin bzw. Experten für das eigene Erleben. Verwenden Sie klare, wörtliche, respektvolle Kommunikation; gewähren Sie Verarbeitungszeit und schriftliche Optionen. Validieren Sie Interessen als legitim und identitätsbildend. Seien Sie beim Doppelt-Empathie-Problem in Peer- und Klinik-Interaktionen aufmerksam. Schaffen Sie **Vorhersagbarkeit** um Termine und reduzieren Sie unnötige soziale/sensorische Last (Autism Awareness Australia; F. Murray, 2023).

(c) Wie Sie anregen / einbeziehen. Lenken Sie Spezialinteressen in **Studium, Projekte, Portfolios, Ehrenamt und frühe Berufs erkundung** — sie sind der größte motivationale und kompetenzaufbauende Gewinn des Jugendlichen. Unterstützen Sie **Identität und Community**: autistische Peer-Gruppen, Spezialinteressen-Clubs, Mentoring und Online-autistische Communities können das Wohlbefinden transformieren. Lehren Sie **Selbstverständnis** des Monotropismus, damit die junge Person für ihre Aufmerksamkeitsbedürfnisse eintreten kann (statt „Ich bin faul/kaputt“ zu verinnerlichen).

(d) Wie Sie unterstützen / umgehen. Gehen Sie proaktiv **psychische Gesundheit** an; screenen Sie auf Angst, Depression, Burnout und Suizidalität, und erkennen Sie, dass **autistisches Burnout von Depression** und von beruflichem Burnout zu unterscheiden ist und *reduzierte Anforderungen, Akzeptanz und Entmasken* erfordert, nicht bloß CBT oder Antidepressiva (Raymaker et al., 2020). Unterstützen Sie pubertätsbezogene praktische und sensorische Bedürfnisse (Menstruation, Hygiene, Körperveränderungen) explizit und konkret (ARI). Thematisieren Sie **Camouflaging-Schaden** — reduzieren Sie die Erwartung zu masken explizit. Lehren Sie Selbstmanagement von Meltdown/Shutdown und sorgen Sie dafür, dass die junge Person einen Weg der Erholung mit geringer Anforderung hat. Planen Sie **Übergänge ins Erwachsenenalter** (Bildung, Arbeit, Gesundheitsübergabe) früh und mit den Interessen der jungen Person im Zentrum. *(Inferenz, gekennzeichnet: Die meiste klinische Leitlinie hier ist aus der erwachsenen Burnout-/Masking-Literatur und autistischen Erfahrungsberichten extrapoliert statt aus adoleszenzspezifischen RCTs.)*

3.4 Erwachsenenalter (etwa 19–Mitte des Lebens)

(a) Was Sie beobachten könnten. Viele autistische Erwachsene — besonders Frauen, People of Colour und solche ohne intellektuelle Beeinträchtigung — werden **erst im Erwachsenenalter diagnostiziert** (die „verlorene Generation“, Lai & Baron-Cohen). In der richtigen Umwelt bringen monotrope Erwachsene **tiefe Expertise, anhaltende Konzentration, Verlässlichkeit, Mustererkennung und Ehrlichkeit** ein, die echte Stärken sind. In der falschen Umwelt — Großraumbüros, ständige Unterbrechungen, unklare Erwartungen, sensorische Last, sozial-politische Anforderungen — erleben sie chronische Erschöpfung, Masking, Meltdowns/Shutdowns und **autistisches Burnout** (Knight, 2021/2022; Booth, 2021; Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022).

(b) Wie Sie interagieren. Kommunizieren Sie **explizit und schriftlich**; definieren Sie Erwartungen, Fristen und soziale Normen konkret statt zu implizieren. Erlauben Sie schriftliche/asynchrone Kommunikation (E-Mail, Text), die die Kanal last senkt. Gewähren Sie Verarbeitungszeit; lesen Sie eine Pause nicht als Widerstand. Fragen Sie die Person, welche Anpassungen helfen — sie ist die Expertin (F. Murray, 2023; Knight, 2021).

(c) Wie Sie anregen / einbeziehen (Arbeitsplatz). Strukturieren Sie die Rolle um **wenigere, tiefere „Tunnel statt Aufgaben“** (Knight, 2021): minimieren Sie Meetings und Unterbrechungen, bündeln Sie flache Arbeit, erlauben Sie Flow-Zeit und geben Sie Zugang zu ruhigem/sensorisch kontrolliertem Raum. Passen Sie Aufgaben an **Stärken und Spezialinteressen** an; die Intensität autistischen Fokus ist, wenn geschützt, ein wesentlicher Produktivitäts- und Innovationsgewinn (Advanced Autism Services, 2025; Sachs Center; Booth, 2021). Bauen Sie **Routinen** mit dem Erwachsenen auf, und nutzen Sie rechtlich verfügbare Anpassungen (z. B. ADA/Equality Act) (Links ABA). Ermutigen Sie zu **„small living“**, wo hilfreich — das Leben auf wenige Fokusbereiche zu vereinfachen, kann Funktion und Glück merklich verbessern (Knight, 2021).

(d) Wie Sie unterstützen / umgehen. Behandeln Sie **autistisches Burnout** als ernste, eigenständige klinische Entität: erkennen Sie chronische Erschöpfung, Verlust zuvor gehaltener Fähigkeiten und verminderte Reiztoleranz; untersuchen Sie auf Suizidalität (Raymaker et al., 2020). Die evidenzgestützte Erholungsrichtung lautet

Anforderungen und Erwartungen reduzieren, Akzeptanz und soziale Unterstützung bieten und „Dinge auf autistische Art tun“/Entmasken erlauben (Raymaker et al., 2020; Mantzalas et al., 2022). Verschreiben Sie *kein* Masking-basiertes Sozialkompetenztraining als Lösung. Behandeln Sie begleitende Angst, Depression, ADHD, Schlaf- und GI-Zustände (die bei autistischen Erwachsenen häufiger sind). Achten Sie, dass **Spezialinteressen schützend und wiederherstellend sind**, keine zu begrenzenden Zwänge (Mantzalas et al., 2022).

3.5 Ältere Erwachsene & hochbetagte Menschen (etwa 60+)

(a) Was Sie beobachten könnten — und die ehrlichen Grenzen unseres Wissens. Dies ist der **am wenigsten erforschte Teil der autistischen Lebensspanne**: Stand 2024 machte Forschung zu älteren autistischen Erwachsenen nur etwa **0,4 % der Autismus-Literatur** aus (wächst aber ~392 % seit 2012) (Klein et al., 2024). Was an Evidenz existiert, ist besorgniserregend: Die Ergebnisse für ältere autistische Erwachsene sind **generell schlecht** über alle vier Domänen des „guten Alter(n)s“ (Gesundheit und Funktionieren; kognitive und körperliche Funktion; positiver Affekt und Kontrolle; soziale Teilhabe). Sie zeigen **mehr medizinische Zustände, geringe adaptive Fähigkeiten, erhöhtes Risiko kognitiven Rückgangs, eingeschränkte körperliche Aktivität, hohe Raten psychischer Zustände, niedrige Lebensqualität und verminderte soziale/community-Teilnahme** (Klein et al., 2024). In einer australischen Stichprobe (Alter 40+) erfüllten nur **3,3 % die Kriterien für „erfolgreiches Altern“** (Klein et al., 2024). Ältere autistische Erwachsene haben **höhere Raten der meisten Gesundheitszustände** — affektive Störungen, Schlafprobleme, GI- und Herz-Kreislauf-Zustände — als nicht-autistische Peers (Additude, zusammenfassend Bevölkerungsstudien). Viele ältere autistische Menschen sind **undiagnostiziert** („verlorene Generation“); Klinikerinnen und Kliniker müssen bereit sein, Autismus bei älteren Erwachsenen zu erkennen, die mit lebenslangen sozialen/sensorischen Unterschieden, Burnout oder psychischer Krise vorstellig werden (OAR; Klein et al., 2024).

(b) Wie Sie interagieren. Alle Querschnittsprinzipien gelten mit zusätzlichem Gewicht: klare, wörtliche, respektvolle Kommunikation; gewähren Sie reichlich Verarbeitungszeit und schriftliche Information;

reduzieren Sie sensorische Last (Hör- und Sehveränderungen verstärken die baseline-Sensorik-Unterschiede); schließen Sie nie von einer langsamen oder atypischen Reaktion auf kognitive Inkapazität. Berücksichtigen Sie das **Doppelt-Empathie-Problem** explizit in Versorgungssettings.

(c) Wie Sie anregen / einbeziehen. Bewahren und **schützen Sie lebenslange Spezialinteressen und Routinen** — diese sind Anker von Identität, Kognition und Wohlbefinden und mögen besonders schützend sein, wenn sich andere Kapazitäten verändern. Passen Sie Aktivitäten an **sich verändernde körperliche und sensorische Fähigkeiten** an, statt sie zu streichen. Unterstützen Sie **autistische Community und Verbindung**, um die schwere soziale Isolation dieser Gruppe zu bekämpfen (Klein et al., 2024; OAR). Ermutigen Sie zu sanfter, der Person angepasster körperlicher Aktivität (körperliche Inaktivität ist ein identifiziertes Problem) (Klein et al., 2024).

(d) Wie Sie unterstützen / umgehen.

- **Zugang zur Gesundheitsversorgung** ist eine kritische Lücke: Viele ältere autistische Erwachsene meiden Versorgung aufgrund lebenslang negativer Erfahrungen und sensorischer/Kommunikations-Barrieren; Kliniken brauchen Schulung (OAR; siehe Teil 4).
- Achten Sie auf **autistisches Burnout** — das Risiko akkumuliert über Jahrzehnte des Masking und unerfüllten Bedarfs und kann als Depression oder „altersbedingter Rückgang“ falsch gelesen werden (Raymaker et al., 2020).
- Seien Sie aufmerksam auf **kognitive Veränderung vs. autistischen Unterschied**: autistische monotrope/Trägheits-Muster von echter **Demenz/kognitiver Dekline** zu unterscheiden ist klinisch schwierig und untererforscht; unterstellen Sie nichts. Es gibt *sehr begrenzte* Forschung zu Autismus + Demenz/Alzheimer — kennzeichnen Sie Unsicherheit und untersuchen Sie sorgfältig (ABTAB; Klein et al., 2024).
- **Versorgungsumwelten** (Pflegeheime, Krankenhäuser) sind oft sensorisch feindselig und routine-störend; treten Sie ein für ruhige Räume, vorhersagbare Routinen, den Verbleib bedeutsamer Objekte/Interessen und Autismus-Schulung des Personals.

- Unterstützen Sie **Palliativ- und Vorsorgeplanung** mit klarer, wörtlicher Kommunikation und Respekt vor der Autonomie.
- *Inferenz, gekennzeichnet:* Weil autismus-spezifische Evidenz im hohen Alter dünn ist, wendet dieser Abschnitt weitgehend das Lebensspannen-Monotropismus-Modell plus allgemeine Befunde zum Altern-mit-Autismus an; behandeln Sie es als Best-Practice-Leitlinie, nicht als etabliertes Protokoll.

Teil 4 — Spezifische Leitlinie für Gesundheitsfachleute

Gesundheitssettings (helles fluorescentes Licht, unvorhersehbare Wartezeiten, vage Instruktionen, sensorische und soziale Anforderungen, Schmerz und Invasivität) gehören zu den schwersten Umwelten für monotrope Menschen und lösen häufig Shutdowns, Meltdowns und Versorgungsvermeidung aus (Autism Society, 2025; PMC11305600 narrativer Review zu autismus-freundlicher Gesundheitsversorgung). Das Folgende ist der autismus-freundlichen Gesundheitsliteratur und dem **AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT)** entnommen (autismandhealth.org).

Vor dem Besuch

- **Bieten Sie einen Vorab-Fragebogen / den AHAT an**, um die spezifischen sensorischen, Kommunikations- und Verfahrensbedürfnisse des Individuums zu erfassen und einen personalisierten Anpassungsbericht zu erstellen (AASPIRE).
- **Geben Sie schriftliche, wörtliche Information** darüber, was passieren wird, in welcher Reihenfolge und wie lange es dauert; bieten Sie Fotos von Raum/Personal an, wenn möglich.
- **Bieten Sie Terminwahl:** erster/letzter Termin (am ruhigsten), kürzere Wartezeiten, keine überlappenden lauten Kliniken.
- Erlauben Sie der Person, eine **vertraute Bezugsperson** mitzubringen und ihr eigenes **sensorisches Werkzeugset** (noise-cancelling-Kopfhörer, Sonnenbrille, Fidget-Artikel) (CHOP; Grateful Care ABA).

Während des Besuchs

- **Reduzieren Sie sensorische Last:** dimmen oder weiches Licht, wo möglich, minimieren Sie Piepen, bieten Sie einen ruhigen Raum, meiden Sie starke Gerüche/Parfüm (Autism Spectrum News; CHOP).
- **Kommunizieren Sie wörtlich und konkret:** erklären Sie jeden Schritt *vor* der Ausführung; sagen Sie, was Sie meinen; meiden Sie Redewendungen; prüfen Sie Verständnis, indem Sie die Person bitten, zusammenzufassen; **gestatten Sie lange Schweigepausen zur Verarbeitung.**
- **Erzwingen Sie keinen Blickkontakt;** erlauben Sie der Person wegzuschauen, zu stimmen oder schriftlich/über Tastatur/AAC zu kommunizieren.
- **Gehen Sie langsam vor; bieten Sie Pausen.** Halten Sie ein sensorisches Ablenkungs-Set bereit (CHOP).
- **Achten Sie den Aufmerksamkeitstunnel:** Wenn die Person ein Interesse oder Stimming zur Selbstregulation während eines Eingriffs nutzt, unterbrechen Sie es nicht.
- Wenden Sie die **Doppelt-Empathie-Haltung** an (Milton, 2012; Neurodivergent Insights): Wenn die Kommunikation stockt, unterstellen Sie eine *gegenseitige* Lücke und passen Sie sich an, statt die Patientin bzw. den Patienten als „schwierig“ oder „non-compliant“ zu etikettieren.

Nach dem Besuch

- Geben Sie **schriftliche Nachbereitung** (Diagnose, Instruktionen, nächste Schritte) in wörtlicher Sprache.
- Planen Sie **Erholungszeit** ein und warnen Sie, dass die Person danach ruhen/shutdownen muss.
- Dokumentieren Sie wirksame Anpassungen in der Akte, damit sie beim nächsten Mal automatisch sind.

Klinisch kritische Erkennungen

- **Autistisches Burnout ist keine Depression.** Es zeigt sich als chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust und verminderte Reiztoleranz, angetrieben durch kumulative Last und eine Erwartungen–Fähigkeiten-Diskrepanz; es als Depression zu

behandeln (oder die Patientin bzw. den Patienten zum „Mehranstrengen“ zu drängen) kann es vertiefen und Suizidalität riskieren. Erholung erfordert reduzierte Anforderungen, Akzeptanz und Erlaubnis zu entmasken (Raymaker et al., 2020).

- **Masking in der Klinik ist häufig und kostenintensiv.** Eine Patientin bzw. ein Patient, die/der in einem 15-Minuten-Termin „gut wirkt“, könnte camouflieren und danach dafür bezahlen; lassen Sie eine maskierte Präsentation nicht Selbstbericht oder Anamnese überstimmen (Pearson & Rose, 2021; F. Murray, 2023).
 - **Schmerz und Interozeption.** Eine monotrope Person bemerkt oder meldet Schmerz, Hunger, Durst, Erschöpfung oder innere Symptome vielleicht erst, wenn sie schwer sind (Kelly Mahler, 2024; Lawson). Setzen Sie „nicht klagen“ nicht mit „nicht leiden“ gleich; fragen Sie proaktiv, und berücksichtigen Sie, dass gemeldete Symptommuster verzögert oder atypisch sein können.
 - **Medikation & Nebenwirkungen.** Autistische Menschen berichten häufig atypische sensorische und emotionale Reaktionen auf Medikamente; beginnen Sie niedrig, titrieren Sie langsam und überwachen Sie Selbstbericht sorgfältig.
 - **Meltdown/Shutdown in der Klinik.** Diese sind unwillkürlich: reduzieren Sie Stimulation, senken Sie Anforderungen, sichern Sie Sicherheit, geben Sie Zeit und Raum, fixieren oder bestrafen Sie nicht; ein Rückzug/Shutdown braucht ruhige, input-arme Geduld, keinen Druck zu „engagieren“ (Autism Society, 2025; Leicestershire Partnership NHS Trust; Reframing Autism).
 - **Einwilligung & capacity.** Geben Sie Information in zugänglicher, wörtlicher Form; gewähren Sie Verarbeitungszeit und unterstützte Entscheidungsfindung; unterstellen Sie niemals aus atypischer Kommunikation einen Kapazitätsmangel.
 - **Anpassungen helfen allen.** Sensorisch-freundliche, vorhersagbare, klar kommunizierte Versorgung kommt auch Patientinnen und Patienten mit ADHD, PTBS, Angst, Sensorikverlust, kognitiver Veränderung und vielen anderen zugute (UNC Health, 2025).
-

Teil 5 — Was Sie vermeiden sollten (häufiger Schaden)

- Eine Person abrupt aus einem Aufmerksamkeitstunnel herausziehen oder Flow wiederholt unterbrechen (F. Murray, 2023).
- Stims, Blickkontakt-Unterschiede oder natürliche Kommunikation abtrainieren (Compliance-basierte „Normalisierung“) — erhöht Masking und langfristigen Schaden (F. Murray, 2023; Raymaker et al., 2020).
- Spezialinteressen als „Zwänge“ rahmen, die einzuschränken seien; Interessen-Zugang reduzieren (Mantzalas et al., 2022).
- Routinen/Erwartungen der Person *aufzuerlegen*, statt sie mitzuschaffen (F. Murray, 2022).
- Defizit-basierte, pathologisierende Sprache verwenden; alle Interaktionsprobleme der autistischen Person zuschreiben (Milton, 2012).
- Autistisches Burnout als Depression oder Faulheit behandeln; die Person zu mehr Masking drängen (Raymaker et al., 2020).
- Sensorisch-feindselige Kliniken, Überraschungs-Eingriffe und vage Instruktionen (PMC11305600; AASPIRE).
- Lebenslange Unterschiede einer älteren Person als „bloßes Altern“ oder Demenz annehmen ohne sachgemäße Untersuchung (Klein et al., 2024).

Teil 6 — Offene Fragen & Evidenz-Vorbehalte (für ehrliche Praxis)

1. **Das hohe Alter ist eine Forschungslücke.** Die meiste Lebensspannen-Leitlinie für Hochbetagte ist extrapoliert; Autismus + Demenz, Autismus + Menopause/Andropause und Palliativversorgung sind weitgehend unstudiert (Klein et al., 2024). Seien Sie gegenüber Patientinnen, Patienten und Familien transparent über Unsicherheit.
2. **Monotropismus ist deskriptiv, noch nicht mechanistisch oder vollständig getestet.** Er ist eine ausgezeichnete klinische Heuristik mit wachsender konvergenter Stütze, aber keine Diagnose oder vollständige Theorie (Dwyer, 2021; 2025).
3. **Nicht alle autistischen Menschen sind monoton.** Eine Minderheit identifiziert sich nicht mit dem Rahmen; stellen Sie das Individuum

stets ins Zentrum (monotropism.org).

4. **Intersektionalität ist unterbelichtet.** Die meiste Forschung ist weiß, westlich, verbal und niedrigeren-Unterstützungsbedarf-biased; Präsentation, Diagnose und Bedürfnisse unterscheiden sich über Geschlecht, Ethnizität, intellektuelle Fähigkeit und Kommunikationsprofile (Raymaker et al., 2020 Limitationen).
5. **Ko-Vorkommen ist die Regel.** ADHD (AuDHD), Angst, Depression, Lernunterschiede, GI-/Schlaf-Zustände treten häufig gemeinsam auf; Monotropismus mag die AuDHD-Überschneidung erklären helfen, und die Monotropism-Questionnaire-Werte sind bei AuDHD am höchsten (Garau et al., 2023; NAS, 2025).

Quellen

1. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398> — via <https://monotropism.org/murray-lesser-lawson>
2. Murray, F. (2018, aktualisiert 2025). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
3. Murray, F. (2023). Monotropism and Wellbeing (Keynote, Scottish Autism Research Group 2023). <https://monotropism.org/wellbeing>
4. Murray, F. (2019). Monotropism at School (ursprünglich in *Tes*).
<https://monotropism.org/school/> — indiziert unter <https://monotropism.org/in-practice>
5. Murray, F. (2022). Understanding how routines can help autistic people thrive. *Thinking Person's Guide to Autism*.
<https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
6. National Autistic Society (Edgar, H. & Adkin, T., 2025). What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism.
<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>
7. Dwyer, P. (2021). Revisiting monotropism. *Autistic Scholar*.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>

8. Dwyer, P. (2025). Monotropism: between obsessive joy and overwhelm. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
9. Garau, V. et al. (2023). Development and validation of a novel self-report measure of monotropism (the Monotropism Questionnaire). OSF-Preprint. <https://osf.io/ft73y/> — Werkzeug unter <https://dlcincluded.github.io/MQ/>
10. Landry, R. & Bryson, S. (2004). Impaired disengagement of attention in young children with autism. *J Child Psychol Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>
11. Sacrey, L.-A. et al. (2015). Attention disengagement in autism spectrum disorder: a meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev*, 56, 111–121.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>
12. Heasman, T. et al. (2024). Autistic flow theory. (Zitiert in NAS, 2025.)
13. Raymaker, D. M. et al. (2020). "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32851204> — Volltext:
https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378
14. Mantzalas, J. et al. (2022). A conceptual model of risk and protective factors for autistic burnout. *Autism Research*.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aur.2722>
15. Pearson, A. & Rose, K. (2021). A conceptual analysis of autistic masking: understanding the narrative of stigma and the illusion of choice. *Autism in Adulthood*, 3(1).
<https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/aut.2020.0043>
16. Bradley, L. et al. (2021). Autistic adults' experiences of camouflaging and its perceived impact on mental health. *Autism in Adulthood*, 3(4), 320–329. (PubMed 36601637.)
17. Milton, D. (2012). On the epistemic and ontological value of the double empathy problem. *Dis & Soc*. Zusammenfassung: Reframing Autism, <https://reframingautism.org.au/miltons-double-empathy-problem-a-summary-for-non-academics>
18. Lawson, W. (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley. — und Lawson, W. (2025). Research by autistic

- researchers: an 'insider's view' into autism. *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063/>
19. Wood, R. (2019). Autism, intense interests and support in school: from wasted efforts to shared understandings. *Educational Studies*. Zusammenfassung: <https://woodbug.blog/2019/03/27/autistic-children-and-intense-interests-the-key-to-their-educational-inclusion/>
 20. Wood, R. et al. (2022). *Learning From Autistic Teachers*. Jessica Kingsley.
 21. Leatherland, J. (2019). Understanding how autistic pupils experience secondary school (Doktorarbeit, Sheffield Hallam). <http://shura.shu.ac.uk/23231/>
 22. Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: a randomized controlled intervention study. *J Child Psychol Psychiatry*, 47, 611–620. (Referenziert via PMC5683273.)
 23. Donzelli, S. (2021). Autistic play at forest school: pretend play characteristics seen otherwise. *Forest School Association*. <https://forestschoollassociation.org/autistic-play-at-forest-school-pretend-play-characteristics-seen-otherwise/>
 24. Hallett, S. (2021). Loops of concern (Leitlinie zu autistischem Grübeln). <https://medium.com/@sonyahallett/loops-of-concern-ff792eebad03>
 25. Kelly Mahler (2024). Interoception and monotropism. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
 26. Knight, J. (2021). Staying put, monotropism & me (tunnels not tasks); (2022) Applying monotropism. <https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
 27. Booth, J. (2021). Why does work not work for autistic people? <https://janinebooth.com/content/why-does-work-not-work-autistic-people>
 28. BERA (2021). Autism: the benefits of monotropism and flow states and its applications for the classroom. <https://www.bera.ac.uk/blog/autism-the-benefits-of-monotropism-and-flow-states-and-its-applications-for-the-classroom>
 29. Autism Society (2025). Autistic meltdowns and shutdowns (Faktenblatt). <https://autismsociety.org/>

30. Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. Understanding autistic meltdowns and shutdowns.
<https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>
31. Reframing Autism. All about autistic shutdowns: a guide for allies.
<https://reframingautism.org.au/all-about-autistic-shutdown-guide-for-allies>
32. AASPIRE Healthcare Toolkit / Autism Healthcare Accommodations Tool (AHAT). <https://autismandhealth.org>
33. Children's Hospital of Philadelphia (CHOP). Tips for more positive office visits for patients with ASD. <https://www.chop.edu/news/tips-more-positive-office-visits-patients-asd>
34. UNC Health (2025). Autistic patients need better care, accommodations in the medical office. <https://news.unchealthcare.org/2025/04/autistic-patients-need-better-care-accomodations-in-the-medical-office>
35. Autism Spectrum News. Creating sensory-friendly health care environments for autistic patients.
<https://autismspectrumnews.org/creating-sensory-friendly-health-care-environments-for-autistic-patients>
36. Klein, C. B. et al. (2024). Aging well and autism: a narrative review and recommendations for future research. *Healthcare*, 12(12), 1207.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11203987> —
<https://doi.org/10.3390/healthcare12121207>
37. Organization for Autism Research (OAR). Aging on the autism spectrum. <https://researchautism.org/oaracle-newsletter/aging-on-the-autism-spectrum>
38. Lai, M.-C. & Baron-Cohen, S. (2015). Identifying the lost generation of adults with autism spectrum conditions. *Lancet Psychiatry*.
(Referenziert in Klein et al., 2024.)
39. Edgar, H. (2023). Supporting pupils through autistic burnout (Lehrer-Leitlinie). <https://autisticrealms.com/supporting-pupils-through-autistic-burnout-teacher-guide/>
40. Edgar, H. (2024). Autistic young people: skills regression, burnout or a shift in monotropic attentional resources?
<https://autisticrealms.com/autistic-young-people-skills-regression-burnout-or-a-shift-in-monotropic-attentional-resources/>

41. Autism Awareness Australia. Understanding mental health in autistic teenagers. <https://www.autismawareness.com.au/navigating-autism/understanding-mental-health-in-autistic-teenagers>
42. Autism Research Institute (ARI). Understanding and supporting puberty in autistic girls and boys. <https://autism.org/understanding-and-supporting-puberty>
43. Neurodivergent Insights. Autism and the double empathy problem in medicine. <https://neurodivergentinsights.com/the-double-empathy-problem-in-medicine>
44. PieBru (2025). Monotropism: an interest-based account of autism (Quell-Kurzdossier). <https://github.com/PieBru/monotropism/blob/main/monotropism.md>
45. Narrative review: Autism-friendly healthcare — a narrative review of the literature (PMC11305600). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11305600>

Unterstützende Praxis-Ressourcen (oben inline zitiert für praktische Aussagen mit geringerem Risiko)

- Advanced Autism Services (2025). How to support autistic adults in the workplace. <https://www.advancedautism.com/post/how-to-support-autistic-adults-in-the-workplace>
- Sachs Center. Autism workplace accommodations that actually work. <https://sachscenter.com/autism-workplace-accommodations>
- Links ABA. Accessing healthcare as an autistic individual; work and mental health tips for autistic adults. <https://linksaba.com>
- Autism Little Learners. Transitions and autism; smoother transitions in young autistic kids. <https://autismlittlelearners.com>
- Grateful Care ABA. Preparing for doctor visits with autism. <https://www.gratefulcareaba.com/blog/preparing-for-doctor-visits-with-autism>
- ABTAB / Above and Beyond Therapy. Autism aging out; autism shutdown. <https://www.abtaba.com>
- Additude. Aging with autism: cognition, health, loneliness & other factors. <https://www.additudemag.com/aging-with-autism-research>
- Retireguide. Aging with autism: a seniors & caregivers guide. <https://www.retireguide.com/guides/seniors-autism-spectrum>

- Raising Children Network (Australia). Self-identity for your autistic teen. <https://raisingchildren.net.au/autism>
- Autistic Realms (Edgar, H.). Monotropism = happy flow state. <https://autisticrealms.com/monotropism-happy-flow-state>
- Neurodiverse Connection. Embracing autistic children's monotropic flow states. <https://ndconnection.co.uk/blog/embracing-autistic-childrens-monotropic-flow-states>